

项目版本号: V2.0
版本日期: 2021-11-11

中心可行性调查表

我司计划开展一项观察达妥昔单抗 β 和常规治疗在高危神经母细胞瘤患者中疗效和安全性的真实世界研究, 该研究计划入组期 2 年, 随访期暂定 2 年, 分别入组 50 例接受达妥昔单抗 β 和 100 例常规治疗的高危神经母细胞瘤患者进行观察, 患者在维持治疗前需进行过清髓化疗和干细胞移植。目前, 我们正在选择研究中心, 希望得到您的配合支持, 帮助我们了解您所在医院对于参与本研究的一些信息。后续如果您有问题, 可以随时和我们的 CRA 联系。

研究中心基本情况			
研究中心：复旦大学附属儿科医院		地址：上海市闵行区万源路 399 号；枫林路门诊部：上海市徐汇区医学院路 130 号	
主要研究人员信息：			
职责	姓名	电话	邮箱
PI	翟晓文	18017590808	zhaixiaowendy@163.com
Sub-I	钱晓文	13636405337	qxw08@hotmail.com

研究中心参与此次调研的各科室人员			
姓名	科室	电话	邮箱
钱晓文	血液科	13636405337	qxw08@hotmail.com

第一部分

1. 研究中心参研意向及既往经验		
1.1 本中心是否愿意参加此研究?	☒ 是	☐ 否
1.2 本中心过去是否参加过高危神经母细胞瘤相关研究?	☐ 是	☒ 否

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

1.3 本中心目前有多少个高危神经母细胞瘤的项目（包括已经启动以及即将启动、相同机制和不同机制）	无	
1.3.1 如有竞争项目请简单描述:	无	
1.3.2 竞争项目是否与本项目入组可能冲突?	☐ 是	☒ 否
2. 研究中心病源情况及治疗信息		
2.1 本中心对神经母细胞瘤的危险度分级主要参照哪个标准?	美国肿瘤协会（COG）危险度分级	
2.2 本中心过去 3 年内平均每年诊治神经细胞瘤患者人数多少? , 其中: 1) 新发中低危神母每年多少例 2) 新发高危多少例 3) 难治复发多少例	平均每年诊治神经细胞瘤患者: 60 例 1) 新发中低危神母每年: 20 例 2) 新发高危每年: 40 例 3) 难治复发每年: 30 例	
2.3 本中心最近 12 个月内治疗的高危神经母细胞瘤患者人数	60 例	
2.3.1 本中心在过去 12 个月内高危神母患者经过诱导治疗、巩固治疗, 并且正在进行或完成维持治疗的患者人数	60 例	
2.4 本中心高危神经母细胞瘤患者接受维持治疗及随访所在的科室是	肿瘤科	
2.5 本中心高危神经母细胞瘤维持治疗阶段的常规治疗方案是	顺式维甲酸	
2.6 本中心高危神经母细胞瘤患者治疗结束后的常规随访计划	每 2-3 月影像学 and 血 NSE 评估	
2.7 本中心是否对高危神经母细胞瘤患者进行干细胞移植	☒ 是	☐ 否
负责移植治疗的科室是: 血液科		
每年大概接受移植患者数量: 10		
接受移植治疗的患者中:	自体移植比例: 100%	异体移植比例: %
在干细胞移植前, 会进行清髓治疗吗?	☒ 是	☐ 否
2.8 本中心对肿瘤治疗的反应评估标准主要是参考哪个标准?	☐ 1. 国际神经母细胞瘤诊断、分期和治疗反应评估标准 (1993 年)	

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

	☒ 2. 国际神经母细胞瘤反应评估标准会议共识（2017 年） ☐ 3. 其他，请详细说明：	
2.9 如果研究实施，预计每年可入组多少例合格的受试者？ （跟研究者介绍入组时间计划和随访计划）	2-3 例（预计月入组：达妥昔单抗 β 组 1 例/月；常规治疗组 2 例/月）	
2.10 方案里描述的常规检查项目，本中心能否开展？	☒ 是	☐ 否
2.11 方案中涉及到的院内各系统是否具有完善的权限管理和稽查轨迹？ （包括但不限于：HIS, LIS 等）	有	
2.12 病历归档到病案室的时限要求？	3 个工作日	
2.13 归档到病案室的病历是否在溯源或核查时允许查阅？	是	
2.14 院内各系统溯源是否需要付费？或特殊要求？	否	
2.15 本中心是否转介过患者去空港和海南接受研究药物（达妥昔单抗 β ）的治疗，得说符合本研究条件的患者资料，入组本研究，因为海南、天津很多病人，是不符合本研究入组条件的	☐ 是	☒ 否
能否联系这些患者将其在空港或海南博鳌的病历资料带回本中心，并将这些患者纳入到本研究中？	☐ 可以	☒ 不可以
2.16 可接受的招募方式	☒ 广告 ☐ 招募公司 ☐ 其他，请描述：	
备注：		
2.17 是否有合作单位可以推荐患者？	☒ 是	☐ 否
备注：复旦大学附属儿科医院海南、厦门、安徽分院		
2.18 患者病历	☐ 纸质版	☐ 电子版 ☒ 二者均有
2.19 监查员和稽查员是否能够查阅原始资料？	☒ 是	☐ 否

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

2.20 研究者文件夹保存在哪里? 由谁负责? 项目结束后如何存放? 备注: 保存年限? 付费情况?		血液科病房资料柜、沈晨、血液科病房资料柜, 10 年存放, 暂无收费	
2.21 开展研究所需设施/设备:			
网络:	☒ 是 ☐ 否	文件柜:	☒ 是 ☐ 否
		传真机:	☒ 是 ☐ 否
2.22 是否具备紧急抢救所需条件? (包括但不限于: 设施设备、药品、环境和人员配备等)		☒ 是	☐ 否
备注: 抢救车、氧气、吸引器、气管插管、呼吸机、监护设备及 ICU 病房等			
2.23 对于患儿体表面积的计算, 使用公式是?		更号下 (身高 * 体重/3600)	
3. 研究团队信息			
3.1 PI 所在科室的基本情况 (科室名称、医护人员数、本人是否有科研团队等)		血液科	
3.1.1 本科室是否有 GCP 资质		☒ 是	☐ 否
3.1.2 本科室既往是否有参研过多中心研究项目		☒ 是	☐ 否
备注: 2 个, 其中包含 2 个注册临床研究			
3.1.3 研究团队中成员是否都有 GCP 资质		☒ 是	☐ 否
备注: 6 个医生有 GCP 资质, 2 个护士有 GCP 资质			
3.1.4 PI 是否对该研究目的、流程和要求有所了解 (CRA 需向 PI 介绍本研究方案)		☒ 是	☐ 否
3.1.5 PI 是否对研究的入排标准、终点和评估/测量标准进行讨论?		☒ 是	☐ 否
3.1.6 目前 PI 参研过多少注册项目?		参研过 1 项注册项目	
3.1.7 PI 参研的项目是否被核查过? 核查机构是?		☒ 是	☐ 否
3.2 您认为影响入组的因素有哪些?		☐ 研究设计	
		☐ 伦理/合同时限过长	

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

	☒ 药物的价格		
	☒ 药物需自费		
	☐ 受试者补偿少		
	☐ 缺少患者		
	☐ 研究者费		
	☐ 儿童患者或其监护人的因素		
	☐ 其它影响因素, 请详细列举:		
3.3 安全性 (AE/SAE) 定义以及向申办方和 EC 报告的程序讨论			
3.4 主要研究者是否可以在伦理通过前开始审核合同?		☒ 是	☐ 否
备注: 伦理递交后			

第二部分

伦理/GCP 办公室/科研科/人遗办的基本信息			
伦理			
职责	姓名	电话	邮箱
EC 秘书/对外接待人	吴柳娟	021-64931221	fdekirb@126.com
伦理接待时间	周二和周四下午 13: 30-16: 30 (现场接待)		
伦理地址	复旦大学附属儿科医院 7 号楼 205		
GCP 办公室			
职责	姓名	电话	邮箱
机构秘书/对外接待人	朱逸清	021-64932389	fdekigcp@163.com

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

机构接待时间	周二、四下午 13: 30-16: 30 (现场接待)
机构地址	复旦大学附属儿科医院 7 号楼 201 科

科研科			
职责	姓名	电话	邮箱
暂无数据			

科研处接待时间	NA
科研处地址	NA

人遗办			
职责	姓名	电话	邮箱
对外联系人	朱逸清	021-64932389	fdek gcp@163.com

人遗办接待时间	NA
人遗办地址	复旦大学附属儿科医院 7 号楼 201

4.立项			
4.1 立项方式	☒ GCP 办公室 ☐ 科研科 ☐ 其他:		
4.2 医院是否有线上管理系统?	☐ 是	☒ 否	☐ 其他
4.3 是否有立项资料清单?	☒ 是		☐ 否
备注: 给机构发邮件获取			
4.3.1 立项资料是否需盖章件?	☒ 是		☐ 否

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

备注: 仅立项资料清单要求盖章的文件才需盖章, 交 1 份纸质资料		
4.4 是否有立项会?	☐ 是	☒ 否
4.4.1 机构立项前要提前多久递交材料才能赶上当次立项?	一般伦理会前 2 周, 具体根据通知	
4.4.2 是否有立项流程图?	☒ 是	☐ 否
备注: 立项资料邮件发机构邮箱形式审核, 通过后递交纸质文件		
4.4.3 立项完成常规需要多少天? (从完成资料递交到立项通过)	2 周	
4.5 是否可以接受伦理前置?	☒ 是	☐ 否
5.合同		
5.1 合同审核的流程, 请详细说明 (如审核流程、审核时间, 审核相关人员, 线上/线下审核要求):	伦理通过后拟定合同, 研究者确认后发机构邮箱审核。机构自行申请院内审核及合同定稿后的院内盖章流程。	
5.1.1 伦理及合同的审核是否可以同时进行?	☐ 是	☒ 否
5.1.2 合同从审核至定稿, 大概需要多久 (周)	约 2 个月	
5.2 管理费及税费的比例, 请详细说明:	30%管理费, 6%税费。	
5.3 中心是否有自己的合同模板?	☒ 是	☐ 否
备注: 给机构发邮件获取		
5.3.1 中心是否接受申办方/CRO 的合同模板?	☒ 是	☐ 否
5.4 合同签署方要求: 两方 (中心+申办方), 三方 (中心+申办方+CRO), 或其他, 请详述	均可	
5.4.1 合同定稿后, 院内签署需要多久	2 周	
5.5 该中心协议费用主要看 PI 意见还是机构意见?	☒ PI 意见	☐ 机构意见
5.6 中心是否接受申办方/CRO 指定的 SMO?	☒ 是	☐ 否
5.7 合同审核主要联系人?	机构办	
5.8 合同付款信息 (账号、开户行及开户行地址)	账号: 1001160609006888829, 开户银行: 中国工商银行上海市	

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

	康健支行		
5.9 是否需要 CRC 协议同步审核签署?	☐ 是		☒ 否
5.10 是否必须接受指定的 SMO? (可多选)	☐ 是, SMO 名称:	☒ 否	☐ 其他要求: CRO 和 SMO 不可是同一公司。
5.11 CRC 协议完成签署前是否可以召开启动会?	☐ 是		☒ 否
5.12 中心对合同的其它特殊要求	无		
备注:			
6、伦理			
6.1 伦理会频率 (例如: 每月 1 次, 每月的第四周的周二等, 具体请描述)	每季度 1 次, 通常 3、6、9、12 月底		
6.1.1 上次伦理会时间是什么时候? 下次伦理会时间预计什么时候? (尽量收集近 6 个月的伦理会时间)	2022 年 3 月 22 日		
6.2 是否有伦理资料清单?	☒ 是		☐ 否
6.3 伦理清单与立项清单是否一致?	☐ 是		☒ 否
6.4 详述伦理递交的流程 (包括审核流程、审核时间、审核相关人员、线上/线下审核以及资料文件准备要求要求)	电子版递交伦理邮箱形式审查通过后, 即可递交 2 份纸质版资料至伦理办公室。伦理与立项可同步开展形式审查。均通过后一起递交纸质资料。		
6.5 是否强制要求组长单位的伦理批件?	☒ 是		☐ 否
6.6 伦理会之前递交伦理文件的截止时间, 请详细说明:	提前 2 周。3 月份伦理会需 3 月 10 日前递交资料		
6.7 伦理是否有项目管理系统?	☐ 是		☒ 否
6.8 伦理递交和立项实际按逻辑关系是怎么样的? (先立项/后伦理、先伦理/后立项、伦理/立项同步)	伦理/立项同步		
6.9 中心是否同意快审	☐ 是		☒ 否

项目版本号: V2.0

版本日期: 2021-11-11

6.10 伦理审核费用（包括首次、变更、年度审查以及打款账号信息等），请详细说明：	上会 5000 元/次	
6.10.1 伦理费支付要求，请详述（如：伦理会审前支付、或者取批件前支付等）	需要会前缴纳费用	
6.11 伦理对儿童药物临床研究的审查重点	无	
6.12 在 ICF 方面的要求（如年龄的划分）	分为 8 岁、8-18 岁、监护人 3 个版本 ICF	
6.13 伦理上会后需要多久能获取批件？请详细说明：	上会 1 个月左右获批	
6.14 是否服从中心伦理或独立伦理？	不接受中心伦理	
7、人遗办的相关信息		
7.1 中心是否有递交人遗办的经验？	☒ 是	☐ 否
7.2 该中心是否能作为人遗办的组长单位携带其他参加中心进行递交？（Leading site）	☒ 是	☐ 否
7.3 中心是否针对牵头和参加人遗办的中心单独收取费用？	☐ 是	☒ 否
7.4 是否可以接受未过伦理先开展承诺书流程	☐ 是	☒ 否
7.5 是否需要 HGRAC 批件才可以申请承诺书	☒ 是	☐ 否
7.6 人遗办的基本流程，请详细说明：	机构负责，告知伦理通过再具体沟通。	
7.7 研究者是否有人遗办账号？（Leading site）	☐ 是	☒ 否
7.8 医院人遗办提交流程请详述（Leading site）	NA	
7.9 医院法人证书申请流程（Leading site）	NA	
7.10 医院合作单位签章流程（Leading site）	NA	
7.11 遗传办承诺书盖章时间要求（如取得伦理批件后才可盖章）	机构负责，告知伦理通过再具体沟通。	
7.12 人遗办盖章流程	机构负责，告知伦理通过再具体沟通。	
7.13 盖章大概需要的时间	机构负责，告知伦理通过再具体沟通。	

项目版本号：V2.0
版本日期：2021-11-11

调研人员签名

	姓名正楷	签名	日期
调研人员	李雪	李雪	2022 年 03 月 28 日 18 时 11 分 49 秒
审批人	王利超,张能能	王利超,张能能	2022 年 03 月 29 日 07 时 49 分 23 秒,2022 年 04 月 20 日 14 时 41 分 33 秒